

위너넷요양병원 적정성평가 결과 및 등급 향상 컨설팅 보고서

평가대상 2026년 6월 (2주기) 현재 종합점수 61.2점 → 목표등급 3등급 (78점)

목표등급 3등급

본 보고서는 WinCheck⁺ 산출 자료를 기준으로 작성되었습니다. · 작성일 2026. 07. 07.

I 종합 평가 요약

구조영역 / 30점 만점

23.6

획득률 78.7%

진료영역 / 70점 만점

37.6

획득률 53.7%

종합점수 / 100점 만점

61.2

현재 5등급

3등급 목표(78점)까지 부족 점수

+16.8

I 1. 현재 위치와 목표

등급	표준화 점수구간	위너넷 현황
1등급	88 ~ 100	
2등급	79 ~ 87	
3등급 (목표)	71 ~ 78	목표 구간
4등급	63 ~ 70	
5등급 (현재)	63 미만	61.2점

핵심 진단

현재 종합점수 61.2점은 5등급 구간(63점 미만)에 해당합니다. 안정적인 3등급 달성·유지를 위해서는 구간 상단인 78점을 목표로 하며, 이는 현재 대비 **+16.8점** 향상이 필요합니다.

※ 기존 표준(1등급·88점)을 목표로 하면 부족분이 26.8점으로 과대 산정됩니다. 본 보고서는 병원 여건을 고려한 단계적 목표(3등급) 기준으로 부족분과 개선 로드맵을 재산정했습니다.

I 2. 한눈에 보는 우선 개선지표 (부족분 큰 순)

순위	지표	영역	가중치	현재점수	부족분	개선 여지
1	욕창 개선 환자분율 최우선	결과	16	3.2	12.8	최대 개선 여지
2	ADL(일상생활수행능력) 개선 환자분율 최우선	결과	12	2.4	9.6	최대 개선 여지
3	의사 1인당 환자 수	구조	8.5	5.1	3.4	인력 구조 개선 필요
4	간호인력 1인당 환자 수	구조	7.5	4.5	3.0	인력 구조 개선 필요
5	유치도뇨관이 있는 환자분율	과정	3	0.6	2.4	감염관리·제거관리
6	배뇨관리 실시 환자분율	과정	3	0.6	2.4	배뇨관리 기록·실시

※ 부족분 = 가중치(만점) - 현재 획득점수. 가중치가 큰 결과지표(욕창 개선·ADL 개선) 두 항목만으로 전체 부족분 38.8점 중 **22.4점**을 차지 → 3등급 달성의 핵심 지렛대입니다.

II 영역별·지표별 상세 분석

지표명	가중치 (만점)	현황값	표준화 구간	획득점수	획득률	부족분
구조지표						
의사 1인당 환자 수	8.5	31.71명	3구간 (30~34명)	5.1	60%	3.4
간호사 1인당 환자 수	8.5	5.41명	5구간 (6명 미만)	8.5	100%	0
간호인력 1인당 환자 수	7.5	4.31명	3구간 (4~5명)	4.5	60%	3.0
약사 재직일수율	5.5	100%	5구간 (100%)	5.5	100%	0
구조영역 소계	30			23.6	78.7%	6.4
과정지표						
유치도뇨관이 있는 환자분율	3	8.7%	1구간 (3.5% 이상)	0.6	20%	2.4
배뇨관리 실시 환자분율	3	0%	1구간	0.6	20%	2.4
항정신성의약품 처방률	3	PI 산출	3구간	1.8	60%	1.2
의약품안전사용(DUR) 점검률	3	100%	5구간	3.0	100%	0
욕창 처치를 실시한 환자분율	4	100%	5구간	4.0	100%	0
결과지표						
욕창이 새로 생긴 환자분율	4	0%	5구간	4.0	100%	0
욕창 개선 환자분율 최우선	16	0%	1구간 (15% 미만)	3.2	20%	12.8
ADL 개선 환자분율 최우선	12	0%	1구간 (15% 미만)	2.4	20%	9.6
당뇨병 HbA1c 적정범위 분율	12	100%	5구간	12.0	100%	0
장기입원(181일 이상) 환자분율	5	46.15%	3구간 (40~60%)	3.0	60%	2.0
지역사회 복귀율	5	50%	3구간	3.0	60%	2.0
진료영역(과정+결과) 소계	70			37.6	53.7%	32.4
종합	100			61.2	61.2%	38.8

※ 표준화 구간은 2024년(2주기 6차) 평가결과 기준(1구간 미흡 ~ 5구간 우수). 획득점수 = 가중치 ÷ 5 × 표준화구간.
※ 항정신성의약품 처방률은 타 기관의 상병 구성·평균 처방률 확인이 불가하여 시스템 산출 PI값이 실제 평가결과와 차이가 있을 수 있습니다(참고용, 기본 표준화 3구간 산정).
※ 유치도뇨관 관련 의무기록(환자별 Foley 삽입·제거 대사)은 병원 EMR/OCS 정보 확인이 필요하여 본 보고서에서는 제외했습니다.

III 지표별 분석 내용

각 지표의 산정 근거(분모·분자·현황값 → 표준화구간 → 획득점수)와 지표 정의, 개선 방향을 정리했습니다. 점수는 (획득점수 / 가중치 만점) 표기.

구조지표

의사 1인당 환자 수 5.1 / 8.5점

분석 2026년 6월, 평균 재원환자 52.95명 ÷ 의사 1.67명 = 의사 1인당 **31.71명**으로 표준화 3구간(30~34명), 가중치 8.5점 중 5.1점 산정. 지표 정의: 월평균 재원환자수를 상근 환산 의사 수로 나눈 값. 값이 작을수록 우수(26명 미만 = 5구간).

개선 26~30명(4구간, +1.7점)·26명 미만(5구간, +3.4점). 의사 인력 총원이 필요한 구조 항목으로, 우선 의사 재직·근무일수 산정 정확성을 점검.

간호사 1인당 환자 수 8.5 / 8.5점 · 만점

분석 평균 재원환자 52.95명 ÷ 간호사 9.78명 = 간호사 1인당 **5.41명**으로 표준화 5구간(6명 미만), 가중치 8.5점 만점 산정. 값이 작을수록 우수(6명 미만 = 5구간). 현재 최고 구간으로 추가 개선 여지 없음(유지).

간호인력 1인당 환자 수 4.5 / 7.5점

분석 평균 재원환자 52.95명 ÷ 간호인력 12.28명 = 1인당 **4.31명**으로 표준화 3구간(4~5명), 가중치 7.5점 중 4.5점 산정. 지표 정의: 간호사+간호조무사 등 간호인력 기준 1인당 환자수. 값이 작을수록 우수(3명 미만 = 5구간).

개선 3~4명(4구간, +1.5점)·3명 미만(5구간, +3.0점). 간호인력 총원 및 근무일수 산정 정확성 점검.

약사 재직일수율 5.5 / 5.5점 · 만점

분석 약사 재직일수율 100%로 표준화 5구간, 가중치 5.5점 만점 산정. 지표 정의: 평가대상기간 중 약사 재직일수 비율(100% = 5구간). 현재 최고 구간으로 유지.

과정지표

유치도뇨관이 있는 환자분율 0.6 / 3점

분석 재원 46명 중 유치도뇨관 보유 4명 = **8.7%**로 표준화 1구간(3.5% 이상), 가중치 3점 중 0.6점 산정. 지표 정의: 유치도뇨관(Foley) 보유 환자 비율. 값이 낮을수록 우수. 구간: 3.5% ↑ (1)·2.5~3.5%(2)·1.5~2.5%(3)·0.5~1.5%(4)·0.5% 미만(5).

개선 불필요 유지 여부 정기 검토·조기 제거, 간헐적 도뇨(CIC) 전환. 제거 시 제거일자를 평가표에 정확히 입력 (누락 시 계속 보유로 집계). 2.5~3.5% 감축 시 2구간(+0.6점).

배뇨관리 실시 환자분율 0.6 / 3점

분석 배뇨관리 대상 18명 중 실시 0명 = 0%로 표준화 1구간, 가중치 3점 중 0.6점 산정. 지표 정의: 배뇨장애·유치도뇨관 대상 환자에 대한 배뇨관리(일정한 배뇨/방광훈련/규칙적 도뇨) 실시 비율.

개선 대상 환자별 배뇨관리 계획 수립 후 평가표의 배뇨관리 항목(일정한 배뇨·방광훈련·규칙적 도뇨)을 체크·기록. 실제 시행 대비 기록 누락 여부 우선 점검.

항정신성의약품 처방률 1.8 / 3점

분석 시스템 산출 처방률(PI) 기준 표준화 3구간, 가중치 3점 중 1.8점 산정(기본 표준화 3구간 산정 항목). 지표 정의: 항정신성의약품 처방 정도(PI, 0.2 미만 = 5구간 / 1.6 이상 = 1구간). ※ 타 기관 상병 구성·평균 처방률 확인 불가로 PI값은 실제 평가결과와 차이가 있을 수 있어 참고용입니다.

의약품안전사용서비스(DUR) 점검률 3 / 3점 · 만점

분석 DUR 점검률 100% 가정으로 가중치 3점 산정하였으나, 매월 심사평가원의 DUR 점검 현황을 확인하여 누락 대상자 관리가 필요하며 점검 결과에 따라 추후 결과 발표 시 점수차가 발생할 수 있음. 확인경로: 요양기관업무포털(biz.hira.or.kr) > 모니터링 > DUR정보 > 기관별 DUR 점검완료현황.

욕창 처치를 실시한 환자분율 4 / 4점 · 만점

분석 1단계 이상 욕창 보유 환자에 대한 피부 처치 실시율 100%로 표준화 5구간, 가중치 4점 만점 산정. 지표 정의: 1단계 이상 욕창 보유 환자 중 당일 피부문제 처치를 실시한 환자 비율(압력 감소 도구·체위변경·영양 공급·드레싱 등 4가지 중 수행 시 해당).

결과지표

욕창이 새로 생긴 환자분율 4 / 4점 · 만점

분석 고위험대상 34명 중 2단계 이상 욕창 발생 환자가 없으므로 0%, 표준화 5구간, 가중치 4점 만점 산정. 지표 정의: 당일·전월 모두 고위험군 환자 중 당일 2단계 이상 욕창이 새로 생긴 환자 확인. 값이 낮을수록 우수(0.25% 미만 = 5구간).

욕창 개선 환자분율 3.2 / 16점 최우선 개선

분석 욕창 개선 대상 1명 중 개선 0명 = 0%로 표준화 1구간(15% 미만), 가중치 16점 중 3.2점 산정. 지표 정의: 2단계 이상 욕창 보유 환자 중 당일 개선(욕창 단계 수 감소·최고단계 하락)된 환자 비율. 구간: 15% 미만 (1)·30~45%(3)·45~60%(4)·60% 이상(5).

개선 실제 처치·드레싱은 이뤄지나 주차별 창상 사정(PUSH tool 등)·호전 판정이 평가표에 기록되지 않아 0%로 산정되는 경우가 많음. 개선을 30~45% 확보 시 3구간(+6.4점 → 9.6점). 가중치 16점으로 전체 부족분 최대 항목.

일상생활수행능력(ADL) 개선 환자분율

2.4 / 12점

최우선 개선

분석 ADL 개선 대상 38명 중 개선 0명 = **0%**로 표준화 1구간(15% 미만), 가중치 12점 중 2.4점 산정. 지표 정의: 입원 시점 대비 재평가에서 일상생활수행능력이 호전된 환자 비율. 구간: 15% 미만(1)·25~35%(3)·35~45%(4)·45% 이상(5).

개선 재활·기능회복 대상 환자의 입원 초기 ADL과 재평가 ADL을 동일 기준으로 기록하여 호전 건 반영. 물리치료·작업치료 실적과 평가표 연동 점검. 45% 이상 확보 시 5구간(+9.6점 → 12점).

당뇨병 환자 HbA1c 적정범위 분율

12 / 12점 · 만점

분석 당뇨병 검사 대상 15명 중 HbA1c 적정범위 15명 = 100%로 표준화 5구간, 가중치 12점 만점 산정. 지표 정의: 당뇨병 상병 환자 중 HbA1c 검사결과가 적정범위(98% 이상 = 5구간)인 환자 비율. 현재 최고 구간으로 유지.

장기입원(181일 이상) 환자분율

3 / 5점

분석 재원 13명 중 181일 이상 장기입원 6명 = **46.15%**로 표준화 3구간(40~60%), 가중치 5점 중 3점 산정. 지표 정의: 재원환자 중 181일 이상 장기입원 비율. 값이 낮을수록 우수(20% 미만 = 5구간).

개선 20~40%(4구간, +1점). 퇴원계획 수립·지역연계(재가·시설) 강화로 장기입원 비중 관리.

지역사회 복귀율

3 / 5점

분석 지역사회 복귀율 **50%**로 표준화 3구간(40~55%), 가중치 5점 중 3점 산정(기본 표준화 3구간 산정 항목). 지표 정의: 퇴원 환자 중 지역사회(가정 등)로 복귀한 비율. 값이 높을수록 우수(70% 이상 = 5구간).

개선 55~70%(4구간, +1점). 퇴원 후 재가·시설 연계 실적을 정확히 기록 관리.

IV 우선 개선지표별 권고사항

① 욕창 개선 환자분율 · 가중치 16 · 부족분 12.8 · 최우선

현황 0% → 1구간(3.2점). 욕창 보유 환자의 개선(호전) 실적이 집계되지 않아 분자(개선 환자)가 0입니다.

구간 15% 미만(1) · 30~45%(3) · 45~60%(4) · 60% 이상(5)

개선방향 욕창 발생 환자의 주차별 창상 사정(PUSH tool 등)·호전 여부를 평가표에 반드시 기록. 실제 처치·드레싱은 이뤄지나 개선 기록 누락으로 0% 산정되는 경우가 많아 기록 관리가 핵심.

목표: 개선을 30~45% 확보 시 3구간 → +6.4점 (3.2 → 9.6)

② ADL 개선 환자분율 · 가중치 12 · 부족분 9.6 · 최우선

현황 0% → 1구간(2.4점). ADL 개선 대상 38명 중 개선 판정 0명. 입원 시점 대비 재평가에서 호전으로 집계된 건이 없습니다.

구간 15% 미만(1) · 25~35%(3) · 35~45%(4) · 45% 이상(5)

개선방향 재활·기능회복 프로그램 대상 환자의 입원 초기 ADL과 재평가 ADL을 동일 기준으로 기록하여 호전건을 정확히 반영. 물리치료·작업치료 실적과 평가표 연동 점검.

목표: 개선을 45% 이상 확보 시 5구간 → +9.6점 (2.4 → 12.0)

③ 유치도뇨관이 있는 환자분율 · 가중치 3 · 부족분 2.4

현황 8.7% (46명 중 4명) → 1구간(0.6점)

개선방향 유치도뇨관 불필요 유지 여부 정기 검토 및 조기 제거, 간헐적 도뇨(CIC) 전환 검토. 제거 후 제거일자를 평가표에 정확히 입력(제거 누락 시 계속 보유로 집계).

목표: 분율 2.5~3.5%로 감축 시 2구간 → +0.6점 (0.6 → 1.2)

④ 배뇨관리 실시 환자분율 · 가중치 3 · 부족분 2.4

현황 0% (대상 18명) → 1구간(0.6점)

개선방향 대상 환자별 배뇨관리 계획 수립 후 평가표의 배뇨관리 항목(일정한 배뇨/방광훈련/규칙적 도뇨)을 체크·기록. 실제 시행 대비 기록 누락 여부 우선 점검.

⑤ 구조지표: 의사·간호인력 1인당 환자 수 · 부족분 3.4 / 3.0

의사 1인당 31.71명(3구간) → 26~30명(4구간, +1.7점) / 26명 미만(5구간, +3.4점). 간호인력 1인당 4.31명(3구간) → 3~4명(4구간, +1.5점) / 3명 미만(5구간, +3.0점).

개선방향 인력 구조 개선(충원)이 필요한 항목으로 단기 개선은 어려우나, 재직일수·근무시간 산정 정확성 점검으로 소폭 상향 여지가 있습니다. 중장기 인력 계획에 반영 권고.

⑥ 장기입원·지역사회 복귀율 · 각 부족분 2.0

장기입원(181일 ↑) 46.15%(3구간) → 20~40%(4구간)로 낮추면 +1점. 지역사회 복귀율 50%(3구간) → 55~70%(4구간)로 높이면 +1점.

개선방향 퇴원계획·지역연계 강화, 퇴원 후 재가·시설 연계 실적 기록 관리.

V 3등급(78점) 달성 로드맵

I 권장 개선 시나리오

단계	개선 지표	현재	목표 수준	현재점수	목표점수	상승분
1 핵심	ADL 개선 환자분율	0%	45% 이상 (5구간)	2.4	12.0	+9.6
2 핵심	욕창 개선 환자분율	0%	30~45% (3구간)	3.2	9.6	+6.4
3	유치도뇨관 환자분율	8.7%	2.5~3.5% (2구간)	0.6	1.2	+0.6
4	지역사회 복귀율	50%	55~70% (4구간)	3.0	4.0	+1.0

개선 후 예상 종합점수 61.2 → 78.8 (+17.6 · 3등급)

결론

가중치가 큰 결과지표 2종(ADL·욕창 개선)의 실적 기록 정상화만으로 +16.0점을 확보할 수 있어, 여기에 과정 지표를 더하면 78.8점 → 3등급 안정권에 진입합니다. 이 두 지표는 실제 진료·재활은 이뤄지나 개선 판정이 평가표에 기록되지 않아 0%로 산정되는 전형적 사례이므로, 추가 인력·비용 없이 기록·평가 절차 개선으로 달성 가능성이 높습니다.

※ 단기 실행 우선순위: (1) 욕창·ADL 재평가 기록 절차 정비 → (2) 유치도뇨관 제거·배뇨관리 기록 → (3) 퇴원계획(지역연계) 강화. ※ 3등급 안정화 후 2등급(79점 이상) 도약 시에는 구조지표(의사·간호인력 1인당) 개선이 추가로 필요합니다.

I 참고: 현재 vs 목표 점수 비교

구분	현재	개선 후(목표)
구조영역 (30)	23.6	23.6
진료영역 (70)	37.6	55.2
종합 (100)	61.2	78.8
등급	5등급	3등급

본 보고서는 WinCheck⁺ 시스템 산출값(2026년 6월 기준)을 근거로 작성되었으며, 목표등급은 위너넷요양병원의 설정값 3등급(78점) 기준입니다. 실제 평가결과는 심평원 최종 산정 기준 및 자료 확정 시점에 따라 달라질 수 있습니다.